

الصلابة النفسية وعلاقتها بالاضطرابات السيكوسوماتية لدى أمهات التوحديين

إعداد

دينا خالد عبد العظيم

باحثة ماجستير بقسم علم النفس

كلية الآداب، جامعة المنيا

dink93952@gmail.com

الملخص:

هدف البحث الحالي إلي التعرف علي العلاقة الارتباطية بين الصلابة النفسية والاضطرابات السيكوسوماتية لدى أمهات التوحديين، وكذلك الكشف عن الفروق ذات الدلالة الإحصائية بين متوسطي درجات مرتفعي ومنخفضي الصلابة النفسية في الاضطرابات السيكوسوماتية لدى أمهات التوحديين، وذلك من خلال المنهج الوصفي بتطبيق "مقياس الصلابة النفسية لمخيمر (2006) ومقياس الاضطرابات السيكوسوماتية ترجمة السيد أبو النيل (1995) ، وتكونت عينة الدراسة من (176) أم من أمهات أطفال التوحد، وأسفرت النتائج عن وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائيًا عند مستوي (0.01) بين درجات أمهات التوحديين علي مقياس الصلابة النفسية وبعض الاضطرابات السيكوسوماتية (اضطرابات القلب والأوعية، اضطرابات الجهاز الهضمي)، ووجود علاقة ارتباطية عند مستوي (0.05) بين درجات أمهات التوحديين علي مقياس الصلابة وبعض الاضطرابات السيكوسوماتية (اضطرابات الجهاز الهضمي، اضطرابات الجهاز العصبي، تكرار المرض) ، كما توصلت إلي وجود فروق بين مرتفعي ومنخفضي الصلابة في الاضطرابات السيكوسوماتية لصالح منخفضي الصلابة وهذه النتيجة تفسر أن امتلاك أمهات التوحديين لمستوي مرتفع من الصلابة يجعل إصابتهن بالاضطرابات السيكوسوماتية منخفض والعكس صحيح.

الكلمات المفتاحية: الصلابة النفسية _ الأضطرابات السيكوسوماتية _ أمهات أطفال توحّد _ توحّد.

Psychological hardness and its relationship to psychosomatic disorders among mothers of children with autism

Abstract:

The current research aim is to identify the correlation between psychologic rigidity and psychosomatic disorders in the mothers of autistic children, as well as to reveal the statistically significant differences between high and low-stiffness averages of psychological disorders in the mothers of autism children, through the descriptive approach by applying the "Psychosomatic Hardness Scale (2006) and the scale of Psychosomatic disorders translated by Mr. Abu Al-Nil (1995), The study sample consisted of (176) mothers of autistic children, and the results resulted in a statistically significant correlation at the level (0.01) between the degrees of mothers of autism children on the psychological hardness scale and some psychosomatic disorders (heart and vascular disorders, digestive disorders), and the presence of a correlation at a level (0.05) between the degrees of autistic mothers on the hardness scale and some psychosomatic disorders (gastrointestinal disorders, nervous system disorders, recurrence of the disease), and they also found differences between high and low-rigidity in psychosomatic disorders in favor of low-rigidity. This result explains that the

mothers of autistic children's having a high level of stiffness makes their incidence of psychosomatic disorders low and vice versa.

Key Words: Psychological resilience_psychosomatic disorders_mothers of autism children_autism.

المقدمة:

إن التوحد اضطراب نمائي يتعدى تأثيره علي الطفل إلي المحيطين به، لذلك الدور الذي تلعبه أم الطفل التوحيدي يجعلها تعيش خبرات ومشاعر مرافقة لحالة الضغط المتزايد، وبالتالي يهدد صحتها النفسية والجسدية بطريقة مباشرة، إلا أنه قد نجد اختلافاً وتبايناً لدي الأمهات في هذه المسألة، حيث نجد بعض أمهات أطفال التوحد ورغم إصابة أطفالهن إلا أنهم يمتلكون قدرة علي مواجهة هذه الضغوط والتعامل معها بشكل سليم وهذا ينعكس إيجاباً علي تحسن حالة أطفالهن. (فريدة، 2021، 2)

فالتعامل مع الضغوط النفسية يختلف من أم لآخرى باختلاف الأساليب التي يتم استخدامها، فمن هذه الأساليب الصلابة النفسية التي درست بشكل واسع من كوبازا (Kobasa 1979) وتوصلت إلى أنها مجموعة من الخصائص النفسية التي تعمل علي احتفاظ الأفراد بصحتهم النفسية والجسمية علي الرغم من التعرض للأحداث الضاغطة. حيث قد تؤثر الإعاقة على مستوى الصلابة النفسية لأمهات المعاقين وقد تؤدي أيضاً إلى عدم التحكم في أمور الحياة، وقد يحدث العكس فتؤدي الإعاقة إلى خلق شخصية صلبة تنسم بالقدرة على المواجهة والتحدى.

وفي دراسة مقارنة قام بها (Renjak, Mavrinac & Simetin, 2009) حول الصحة المدركة لوالدي الطفل التوحيدي في كرواتيا، توصلت الدراسة إلي أن أولياء الطفل التوحيدي أظهروا صحة متدنية في

مختلف الأبعاد "الصحة الجسدية، الأنفعالية، العملية، الآلام الجسدية، الحيوية والطاقة، والصحة العامة" مقارنة بالولياء الأطفال ذو النمو العادي. (Rentak, Mavrinac &

Simetin, 2009, 403)

ويشير (Dunn et al, 2001) إلي أن أم الطفل التوحدي تظهر درجة من الضغوط أكثر من أمهات الأطفال المصابين بإعاقات أخرى، هذا ما زاد من النتائج الصحية السلبية لدى أمهات أطفال التوحد . (Dunn et al, 2001, p39) وفي هذا الصدد، أشارت العديد من الدراسات والأبحاث إلي أن للأنفعال والضغط النفسي دور هام في إثارة الحالة العضوية، والتي تساهم في نشأه ما يسمى " بالأضطرابات السيكوسوماتية ". حيث أن الضغوط ترهق النفس، وإذا فاقت الضغوط قدره تحملها، فإن الجسد يشاركها في ذلك، وقد يعاني الإنسان من أعراض مختلفة قد تستمر دون معرفة سببها. (بثية، إلهام، 2022، 2)

مشكلة الدراسة

تشير وزارة الصحة الي ان أكثر من (450.000) شخص مصاب بأضطراب "التوحد" لسنة 2021. ويؤثر بدوره على المحيطين به كالأسرة بشكل عام والأم بشكل خاص، فمؤشرات التوحد لدي الطفل بمثابة حدث صادم للأسرة. إذ تشير العديد من الدراسات الي ان أسر الأطفال التوحديين يعانون من ضغوط ومشكلات نفسية أكثر من أسر الأطفال العاديين، حيث أجري (Marcysiask, 1999) دراسة مقارنة في مستويات القلق والضغوط النفسية بين أسر أطفال التوحديين وأسر أطفال العاديين في بولندا، وتوصلت إلي أن مستويات القلق والتوتر لدي أسر أطفال التوحديين أعلى من أسر الأطفال العاديين.

نجد أيضاً دراسة "عبد اللاوي" (2013) بعنوان "الصراع النفسي لدى أمهات التوحديين"، والتي كشفت نتائجها عن مدي تأثيره علي توافق الأم النفسي وبالتالي يؤثر علي الحالة النفسية للأم.

وهذا ما أيدته دراسة **الموافي وآخرون (2017)**، بأن وجود طفل معاق في حياة الأم وتربيته بداية لسلسلة شديدة من الضغوطات والتحديات، مما يتطلب تنمية الصلابة النفسية لديها لمواجهة صعوبات الحياة والإعاقة. (فؤاد، وآخرون 2017، 80)

وتعتبر الأم الشخص الأقرب للطفل التوحدي، وبالتالي فهي تعتبر الشخص الأول المستهدف للتعرض للضغوط النفسية والتي تهدد صحتها النفسية والجسمية. إذ توصلت دراسة (Alik et al, 2006) والتي أجريت حول أمهات الأطفال المصابين بأسبرجر، إلي انخفاض في مستوى الصحة الجسدية لدى الأمهات والتي كانت مرتبطة بخصائص الطفل.

وعليه يتضح أحد جوانب مشكلة الدراسة في الآثار السلبية الناتجة عن تدهور الصحة النفسية الناجم عن وجود طفل معاق والذي يمثل تهديدا لامهات أطفال طيف التوحد من الناحية النفسية والصحية، والتي تظهر على شكل اضطرابات عضوية تسبب عجز للفرد، وهي ما تسمى بالاضطرابات السيكوسوماتية والتي تؤكد على علاقة النفس بالجسد، فالآثار التي تحدثها الضغوط النفسية تظهر بنسبه 30 % على شكل اضطرابات سيكوسوماتية مختلفة. (فيصل، 2000، 66).

وانطلاقا مما سبق يمكننا طرح التساؤلات التالية:

- أ- هل توجد علاقة ارتباطية بين درجات عينة الدراسة من أمهات التوحديين على مقياس الصلابة النفسية وعلى مقياس الاضطرابات السيكوسوماتية ؟
- ب- هل توجد فروق بين متوسطى درجات مرتفعى ومنخفضى الصلابة النفسية فى الاضطرابات السيكوسوماتية لدى أمهات التوحديين ؟

أهداف البحث

1-الكشف عن الارتباط بين الصلابة النفسية لدى أمهات التوحديين والاضطرابات السيكوسوماتية.

2-معرفة الفروق ذات الدلالة الإحصائية بين متوسطي درجات مرتفعى ومنخفضى الصلابة النفسية فى الاضطرابات السيكوسوماتية لدى أمهات التوحديين.

أهمية الدراسة : تأتي أهمية تلك الدراسة:

1-من أهمية موضوع الدراسة وهو الصلابة النفسية والاضطرابات السيكوسوماتية.

2- علي المستوى النظري فإن تقديم الدراسات والبحوث والاطر النظرية في هذا المجال يساهم لمعرفة سبل مواجهة هذه الظاهرة.

3- تسليط الضوء على فئة مهمة لها دور في حياة الطفل المتوحد الذي يحتاج لتربية ومعاملة خاصة ألا وهي فئة أمهات أطفال التوحد خاصة وأن عبء التربية يقع بالدرجة الأولى على الأم.

مفاهيم الدراسة وتعريفاتها الإحرائية

الاضطرابات السيكوسوماتية

يعرف "حامد عبد السلام" بأنها: اضطرابات جسمية موضوعية ذات أساس وأصل نفسي (بسبب الاضطرابات الأنفعالية) تصيب المناطق والأعضاء التي يتحكم فيها الجهاز العصبي الذاتي. (حامد، 2005، 468)

الاضطرابات السيكوسوماتية إجرائياً: هي الدرجة التي تحصل عليها أم الطفل التوحد علي مقياس الاضطرابات السيكوسوماتية المستخدم في البحث الحالي.

الصلابة النفسية

يرى "صالح أحمد القرني وجمال الدين محمد مزكى" أن الصلابة النفسية هي: أحد المتغيرات الإيجابية البناءة في الشخصية والتي تتكون من خلال تفاعل الفرد مع البيئة الطبيعية والاجتماعية المحيطة، وهي أحد متغيرات المقاومة التي تعمل كواق من الأحداث الضاغطة. (صالح، جمال، 2020، 247)

الصلابة النفسية إجرائياً: هي الدرجة التي تحصل عليها أم الطفل التوحد علي مقياس الصلابة النفسية المستخدم في البحث الحالي.

حدود الدراسة

الحدود الموضوعية: وهي ما تضمنته أسئلة البحث في محاولة التعرف علي علاقة الصلابة النفسية بالاضطرابات السيكوسوماتية لدى أمهات التوحديين.

الحدود الزمانية: تتحدد الدراسة من الفصل الدراسي الثاني في 2023-2024.

الحدود المكانية: ببعض المراكز الخاصة (مركز كيان، تواصل، آفاق، الأمل بملوي، مركز كن معي بدير البرشا، مراكز الشباب بقرية " بني احمد_ مقوسة" بمحافظة المنيا).

الإطار النظري :

أولاً: الصلابة النفسية Psychological Hardiness

أ- تعريف الصلابة النفسية

يعرف "سيلفاتورمادي" (2006) الصلابة علي أنها "مزيج معرفي/عاطفي يشكل حاجزاً شخصياً متعلماً وموجهاً للنمو، وهو يتألف من السمات المعرفية والعاطفية والسلوكية ويصف قدرة الأفراد علي الحفاظ علي الحالة الصحية خلال الأوقات المضطربة. (Judkins, 2022, 3)

وتعرف أيضاً بأنها: مزيج من السمات الشخصية التي تساعد الفرد علي التغلب علي التوتر ورؤية الحياة بتفاؤل، ويشمل الالتزام والسيطرة والتحدي والثقة بالنفس وقبول الحياة. (Robiya, 2020, 16)

ب- النظريات المفسرة للصلابة النفسية

1-نظرية سوزان كوبازا (Kobasa;1979): قدمت كوبازا نظرية رائدة في مجال الوقاية والصلابة للإضطرابات النفسية والجسمية وتناولت خلالها العلاقة بين الصلابة النفسية واحتمال الإصابة بالأمراض وقد اعتمدت هذه النظرية علي آراء بعض العلماء أمثال فرانكو وروجرز والتي أشارت إلي أن وجود هدف للفرد أو معني لحياته، يعتمد علي قدرته علي استغلال إمكانياته الشخصية والاجتماعية بصورة جيدة.

2-نظرية مادي Maddi: كشف مادي عن مصدر جديد في مجال الوقاية من الإصابة بالاضطرابات النفسية والجسدية وهي الصلابة النفسية، مؤكداً علي أهمية الصلابة الجسدية والنفسية للفرد، فالأشخاص الأكثر صلابة يتعرضون للضغوط ولا يمرضون، كما تؤثر الصلابة النفسية على مرحلة الطفولة، من خلال معاشة الخبرات

المعززة التي تثري الشخصية وتقوي دعائمها وتظهر من خلال المشاعر والسلوكيات التي تتصف بالالتزام والتحكم والتحدي. (بوجمعة ، 2020 ، 16)

ج- خصائص الأفراد مرتفعي ومنخفضي الصلابة النفسية

1-خصائص الأفراد مرتفعي الصلابة النفسية:

ونلخص ذوي الصلابة النفسية المرتفعة بأنهم يتسمون بدرجة مرتفعة من التحدي للقيام بمهامهم من منطلق الاعتقاد بأن التغير حقيقة ينبغي التعامل معها، لديهم الإمكانية لاستمرارية عملية التوافق مع متطلبات الحياة ، يكونوا أكثر نشاطاً ودافعية ويميلون للقيادة والسيطرة. (أديب، 2009 ، 46)

2-خصائص الأفراد منخفضي الصلابة النفسية:

إن الأشخاص الأقل صلابة، يكونوا أكثر شعوراً بالفشل ونقداً لذواتهم، ويتوقعون التهديد المستمر والضعف في مواجهة الأحداث الضاغطة، وليس لديهم اعتقاد بضرورة الارتقاء، وليس لديهم قدرة علي تحمل المسؤولية، ويتسمون بالبحث الدائم الي المساندة. (حراث، جزارب، 2018 ، 218)

د- أهمية الصلابة النفسية

الصلابة النفسية لها أهمية كبيرة في الحياة، وهي تقي الإنسان من آثار الضغوط الحياتية المختلفة، وهي تجعل الفرد أكثر مرونة، وقابلية للتغلب على مشاكله الضاغطة، كما تعمل علي الحماية من الأمراض الجسدية والاضطرابات النفسية فقد أشارت كوبازا إلى أن الصلابة النفسية ومكوناتها تعمل كمتغير سيكولوجي، يخفف من وقع الأحداث الضاغطة على الصحة الجسمية للفرد. (عماد، 1997 ، 176)

ثانياً: الاضطرابات السيكوسوماتية Psychosomatic Disorder

أ-تعريف الاضطرابات السيكوسوماتية:

اختلفت تعريفات الاضطرابات السيكوسوماتية باختلاف التخصصات والتوجهات العلمية، ويمكن تعريفها بأنها أمراض نفسية السبب تظهر على شكل أعراض جسمية مثل الصداع والقولون وألم العضلات وغيرها ولا يمكن علاجها طبياً بل من خلال العلاج النفسي. (منصور، 2019)

-ينظر " جيموت ولوك " 1984 Jemmot and lock إلى الاضطرابات النفس-جسدية علي أنها النتيجة النهائية للإستثارة الانفعالية المزمنة. تنتج هذه الاضطرابات إما بشكل مباشر عن التغيرات الهرمونية العصبية التي تنطوي عليها الأثارة (الإجهاد) أو بشكل غير مباشر نتيجة لأسستنفاد الوظائف المناعية. (Cited in: woods/Lyons, 1990,4)

ب-النظريات المفسرة للمرض السيكوسوماتي:

1-النظرية التحليلية: تعتمد في تفسيرها على البناء الداخلي للشخصية فهي تفترض وجود علاقة سببية بين مكونات الشخصية والاضطرابات السيكوسوماتية، حيث افترض أتباع فرويد وجود أسباب تحليلية لا شعورية تكمن وراء الإصابة بهذه الاضطرابات وقدموا تفسير قائماً على الدينامية السيكلوجية أي التغيرات النفسية التي يتعرض لها الفرد وخلاصة هذه النظرية أن الأعضاء الجسمية المصابة ليست سوى تعبير رمزي عن بعض الصراعات اللاشعورية التي ينعكس أثرها في صورة القرع وغير ذلك من الاضطرابات السيكوسوماتية. (عبدالرحمن، 2000، 233)

2-النظرية السلوكية : يرى بعض السلوكيين ان الاضطرابات السيكوسوماتية ما هي إلا عادات تعلمها الإنسان ليخفف من قلقه وتوتراته ويجد من خلالها حلاً لصراعاته، كما أن الاضطراب هو نتيجة لتطور عملية تعلم فاشلة تمت عن طريق الاشتراط. (الزهره، ربيعة، 2010)

ج-أسباب الاضطرابات السيكوسوماتية:

- يحدث الانهيار السيكوسوماتي اذ وجد ضعف وراثيا أو مكتسبا للجهاز العضوي.
- يتضمن المرض السيكوسوماتي نكوصا فسيولوجيا ونفسيا يحدث في الأشخاص الأقل نضجاً.
- تشارك بعض أزمات الحياة في الانهيار السيكوسوماتي والميكانيزمات المرضية والقابلة للتشريع والتي تم تشريطها في الطفولة في المراحل المبكرة. (Guttman, 1966, 290)

ثالثاً: التوحد Autism

أ-تعريف التوحد:

تعرف منظمة الصحة العالمية التوحد: علي أنه إضطراب نمائي، تشمل أعراضه الأساسية ضعف القدرة علي التواصل والتفاعل الاجتماعي، الاهتمامات والأنشطة النمطية والمتكررة، انخفاض القدرة الفكرية العامة. (WHO,2013,6)

ويعرف بأنه إضطراب في النمو العصبي يظهر بشكل عام أثناء الطفولة أو عندما يتجاوز الطلب الاجتماعي قدرات الشخص، ويظهر هؤلاء الأشخاص صلابة كبيرة في السلوكيات والإدراك في التكيف والبيئة الجديدة، كما يظهر لديه خلل في تطور الوظائف المعرفية. (Delorme, 2021, 14)

ب- أشكال التوحد

يستخدم المتخصصون مرجعاً يسمى الدليل الأمريكي التشخيصي الخامس (DSM.5) وفي هذا المرجع يتم تشخيص الاضطرابات المتعلقة بالتوحد تحت العناوين التالية: (اضطرابات النمو الدائمة، اضطرابات التوحد، متلازمة أسبرجر Asperger's)

Syndrome ، متلازمة ريت Ret's Syndrome ، اضطراب الطفولة التراجعي). (فاروق، السيد، 2011، 94)

ج- النظريات المفسرة للتوحد:

1-نظرية العقل : تشير إلى ان الأطفال التوحديون بمقدورهم تكوين اعتقادات معينة أو إدراك ما يعتقدونه الآخرون ، وهم لا يستطيعون التعبير عن الانفعالات المختلفة، أما بالنسبة للبيئة الاجتماعية فليس من السهل على أغلبهم فهم البيئة ومكوناتها كما أن سلوكياتهم أغلبها غير مقبولة. (شيرين، 2017، 402)

2-النظرية البيئية: تشير إلى أن الطفل التوحدي يتعرض لمؤثرات قوية في مرحلة مبكرة من حياته تسفر عن إصابته بالاضطراب النفسي الشديد. وقد ظهرت وجهة نظر (تبلهايم) وهي الحرمان العاطفي من العوامل الأساسية المسببة لاضطراب التوحد، ويبدو أن هؤلاء الأطفال ينتمون إلى أسر تتميز بالبرود العاطفي إلى حد كبير وجود المشاعر العاطفية. (رائد، 2006، 167)

3-النظرية العضوية: يرى أن هؤلاء الأطفال يأتون إلى العالم بعجز فطري ذا أساس بيولوجي يعوق نمو الاتصال العادي، لذا يمثل التوحد اضطراب فطري للاتصال الوجداني. كما أنه يعد اضطراباً معرفياً واجتماعياً في الوقت ذاته، وأن هناك أسباب بيولوجية متعددة وليست سبباً واحداً والتي أدت بدورها إلى الآثار السلبية التي تتضمن الملامح الأساسية للتوحد. (شيرين، 2017، 404)

د-أسباب اضطراب التوحد:

1-عوامل جينية وراثية: أظهرت الدراسات التي أجريت حول التوائم وجود فرصة أكبر لأن تصاب التوائم المتماثلة بالتوحد من التوائم الغير متماثلة. وايضاً هناك استدلالات توضح أن مناطق في الكروموزوم (2) و(17) قد تضمن الجين الذي يجعل الأفراد

هدفت دراسة أشرف عبد الحميد (2016) الي معرفة فاعلية برنامج إرشادي في تنمية الصلابة النفسية وآثره في تنمية خفض الضغوط النفسية لدى أمهات أطفال التوحد، وتكونت عينة الدراسة من (24) أمأً، وإشارات اهم النتائج الي وجود فروق دالة احصائياً في القياس البعدي في مستوي (الصلابة النفسية - الضغوط النفسية) لصالح المجموعة التجريبية ، وتوصلت الي عدم وجود فروق دالة احصائيا بين القياس البعدي والتبعي في مستوي (الصلابة النفسية - الضغوط النفسية).

دراسات تناولت الاضطرابات السيكوسوماتية:

دراسة " بثية، إلهام" (2022) هدفت الدراسة إلى الكشف عن ظهور الاضطرابات السيكوسوماتية لدى أمهات أطفال التوحد، وتكونت عينة الدراسة من (5) حالات، تراوحت أعمارهم بين 30 - 50 سنة، وأُعدمت علي مقياس الاضطرابات السيكوسوماتية المقنن في البيئة الجزائرية، وفق المنهج العيادي، وتوصلت نتائجها إلي أن مهات أطفال التوحد تظهر لديهن اضطرابات سيكوسوماتية. وتوصلوا إلى أن بعض الحالات لديهن مقاومة، وعدم تقبل لمرض أطفالهن.

دراسة براجل إحسان (2016): هدفت إلى الكشف عن مصدر الضبط السائد لدى أمهات أطفال التوحد، والكشف عن مستوى الاضطراب السيكوسوماتي لدى أمهات أطفال التوحد، وقد أجريت هذه الدراسة على عينة قوامها 150 أمأً، واستخدمت مقياس روتر لمصدر الضبط، وقائمة كورنل للنواحي السيكوسوماتية والعصابية، وفق المنهج الوصفي، وقد توصلت إلى أن مصدر الضبط السائد لدى أفراد العينة هو الضبط الداخلي. وأن أمهات أطفال التوحد يظهرن درجة شديدة من الإصابة بالاضطراب السيكوسوماتي.

دراسات تناولت العلاقة بين الصلابة النفسية والاضطرابات السيكوسوماتية:

وجاء هدف دراسة عبد المطلب (2017) إلي استقصاء العلاقة بين الصلابة النفسية والاضطرابات النفسجسمية وبعض المتغيرات الديموغرافية علي عينة من المعلمين

والمعلومات في الكويت بإستخدام المنهج الوصفي الارتباطي. وأسفرت عن وجود فروق بينهم في الاضطرابات النفسجسمية مرجعها الجنس والحالة الاجتماعية، كما كشفت عن وجود علاقة إيجابية بين الصلابة النفسية ومعظم مكونات الاضطرابات النفسجسمية، ويعتبر تكرار المرض منبئاً بدرجة الصلابة النفسية التي يتمتع بها أفراد العينة.

وجاء هدف دراسة أبو حسين (2012) هدفت الي التعرف علي مستوي كلا من الصلابة النفسية والأمل وعلاقتها بالأعراض السيكوسوماتية لدي الأمهات المدمرة منازلهن في محافظة شمال غزة، علي عينة قوامها 217 أمّاً، وتوصلت إلي وجود علاقة سالبة دالة احصائياً عند مستوي 0.01 بين الأمل والصلابة النفسية؛ كل علي حدة مع الاضطرابات السيكوسوماتية.

الصلابة هدفت دراسة المشعان (2011) الي إستقصاء العلاقة بين الصلابة النفسية والشكاوي الجسمية والأمل والأنبساط لدي موظفي القطاع الحكومي لدي عينة من الذكور والإناث، وتوصلت الي وجود علاقة ارتباط سالبة بين الصلابة النفسية والأمل، ووجود علاقة سالبة بين الشكاوي الجسمية والأمل والأنبساط، ولا توجد فروق بين الذكور والإناث في الصلابة النفسية والشكاوي البدنية والأمل والأنبساط.

إجراءات الدراسة

أ-منهج الدراسة:

أعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي بهدف التعرف علي الصلابة النفسية وعلاقتها بالاضطرابات السيكوسوماتية لدى أمهات التوحيدين.

ب-عينة الدراسة:

1-عينة الدراسة الاستطلاعية:

تكونت العينة الاستطلاعية من (131) أمًا من أمهات الأطفال التوحديين، بمتوسط عمري (36.07) وانحراف معياري (6.97) .

والهدف من العينة هو التحقق من الخصائص السيكومترية لأدوات الدراسة (مقياس الصلابة النفسية _ مقياس الاضطرابات السيكوسوماتية) وقد أسفرت نتائجها عن معاملات صدق وثبات مرتفعة.

2-عينة الدراسة الأساسية:

تكونت العينة الأساسية من (176) أمًا من أمهات الأطفال التوحديين ، بمتوسط عمري (36.63) وانحراف معياري (7.35) ، والمتوسط العمري لأبنائهن التوحديين (7.27) وانحراف معياري (3.31) ج- أدوات الدراسة :

1- مقياس الصلابة النفسية :إعداد (مخير، 2006)

(1) الوصف العام : مقياس الصلابة النفسية تُعد أداة تُعطي تقديرًا كميًا لصلابة الفرد النفسية ، والمقياس يتكون من (47) عبارة ، وتقع الإجابة على المقياس ضمن 3 بدائل (تنطبق تمامًا 3، تنطبق أحيانًا 2 ، لا تنطبق أبدًا 1)، وتعكس في حالة العبارات (7، 11، 16، 21، 23، 25، 28، 32، 35، 36، 37، 38، 42، 46، 47)، ويتكون من ثلاثة أبعاد وهي :

• الالتزام: ويضم العبارات (1، 4، 7، 10، 16، 19، 22، 25، 28، 31، 34، 37، 40، 43، 46).

• التحكم: ويضم العبارات (2، 5، 8، 11، 14، 17، 20، 23، 26، 29، 32، 35، 38، 41، 44).

• التحدي: ويضم العبارات (3، 6، 9، 12، 15، 18، 21، 21، 24، 27، 30، 33، 36، 39، 42، 45، 47)

(2) الخصائص السيكومترية للمقياس في الدراسة الحالية :

في البداية تم حساب ثبات المقياس عن طريق إعادة التطبيق بفواصل زمني خمسة عشر يوماً حيث تراوحت معاملات الثبات 0.79 مما يدل علي ارتفاع مؤشرات ثبات المقياس.

صدق مقياس الصلابة النفسية :

باستخدام صدق الارتباط بالمحك تم حساب صدق المقياس الراهن من خلال حساب الارتباط بمحك آخر وهو مقياس الصلابة النفسية من إعداد (د. مصطفى نمر) حيث تراوحت معاملات الارتباط بين الدرجة علي المقياس 0.70 مما يدل علي ارتفاع مؤشرات صدق المقياس الراهن.

2- مقياس الاضطرابات السيكوسوماتية: (ترجمة/ أبو النيل، 1995)

(1) الوصف العام : يتكون المقياس من 15 محور تتدرج تحته (81) عبارة، وتم التحقق من الصدق والثبات وتم التوصل إلى أن الأداة تتصف بصدق عالي وثبات عالي، وتم اختيار 5 اضطرابات من المقياس في هذه الدراسة، وهي :
-اضطراب القلب والأوعية :ويشمل العبارات (1، 2، 3، 4، 5، 6) في المقياس الحالي .

-اضطراب الجهاز الهضمي : ويشمل العبارات (7، 8، 9، 10، 11، 12) .

-اضطراب الجهاز العصبي : ويشمل العبارات (13، 14، 15، 16، 17) .

-اضطراب الجهاز العصبي : ويشمل العبارات (18، 19، 20، 21، 22، 23، 24).

-تكرار المرض : ويشمل العبارات (25، 26، 27، 28)

ويتم تصحيح المقياس بناء على التقديرات التالية :تعطى الاستجابة "تنطبق تماماً" الدرجة (3) ، والاستجابة "تنطبق إلى حد ما" الدرجة (2)، ولاستجابة "لا تنطبق إطلاقاً" الدرجة (1) .

(2) الخصائص السيكومترية للمقياس في الدراسة الحالية :

في البداية تم حساب ثبات المقياس عن طريق إعادة التطبيق بفواصل زمني خمسة عشر يوماً حيث تراوحت معاملات الثبات (0.71) مما يدل علي ارتفاع مؤشرات ثبات المقياس.

صدق مقياس الاضطرابات السيكوسوماتية :

باستخدام صدق الارتباط بالمحك تم حساب صدق المقياس الراهن من خلال حساب الارتباط بمحك آخر وهو مقياس الاضطرابات السيكوسوماتية من إعداد (د. هشام كامل) حيث تراوحت معاملات الارتباط بين الدرجة علي المقياس (0.74) مما يدل علي ارتفاع مؤشرات صدق المقياس الراهن.

- نتائج الدراسة وتفسيرها :

أ- نتائج الفرض الأول وتفسيره:

ينص هذا الفرض على أنه "توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائية بين درجات عينة الدراسة من أمهات التوحيدين بين الصلابة النفسية والاضطرابات السيكوسوماتية . وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب معامل الارتباط الخطي لبيرسون coefficient Pearson correlation بين درجات أفراد عينة الدراسة من أمهات التوحيدين بين كل

الصلابة النفسية والاضطرابات السيكوسوماتية ، كما بالجدول التالي:

جدول(1)

معاملات الارتباط الخطية لبيرسون بين عينة الدراسة من أمهات التوحيدين على مقياس الصلابة النفسية ودرجاتهم على مقياس الاضطرابات السيكوسوماتية (ن=176)

المتغيرات	اضطرابات القلب والأوعية الدموية	اضطرابات الجهاز الهضمي	اضطرابات الجهاز العصبي	تكرار المرض
مقياس الصلابة النفسية	-0.224**	-0.254**	-0.182*	-0.178*

** معامل الارتباط دال عند مستوى دلالة 0.01 * معامل الارتباط دال عند مستوى 0.05

يتضح من الجدول السابق وجود علاقة ارتباطية سالبة دالة إحصائية عند مستوى (0.01) بين درجات أمهات التوحيدين على مقياس الصلابة النفسية وعلى بعض الاضطرابات السيكوسوماتية (اضطرابات القلب والأوعية الدموية، اضطرابات الجهاز

الهضمي)، ووجود علاقة ارتباطية سالبة دالة إحصائية عند مستوى (0.05) بين درجات أمهات التوحديين على مقياس الصلابة النفسية وعلى بعض الاضطرابات السيكوسوماتية (اضطرابات الجهاز العصبي، اضطرابات الجهاز العصبي، تكرار المرض).

وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأن هناك علاقة تنافر بين الصلابة النفسية والاضطرابات السيكوسوماتية أي كلما زادت الصلابة النفسية قلت معها الاضطرابات السيكوسوماتية مما يدل على أن الأمهات اللاتي يتمتعن بالصلابة النفسية الأكثر تكن أقل عرضة للاضطراب السيكوسوماتي، فالصلابة النفسية تعمل كحاجز يحول بين الأمهات والإصابة بالأمراض النفسية والجسمية المرتبطة بالضغط، فالأمهات ذات الشخصية الصلبة يتعاملن بصورة جادة وفعالة مع الضغط، كما تميل للتفاؤل والتعامل المباشر مع مصادر الضغط، لذلك فإنها تستطيع تحويل المواقف المسببة للضغط إلى مواقف أكثر تهدئة.

ب- نتيجة الفرض الثاني وتفسيره :

وينص على أنه : "لا توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطي درجات مرتفعي ومنخفضي الصلابة النفسية في الاضطرابات السيكوسوماتية لدى أمهات التوحديين". وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار ت "t-test" للتعرف على الفروق بين متوسط درجات أمهات التوحديين مرتفعي الصلابة النفسية ومتوسط درجات أمهات التوحديين منخفضي الصلابة النفسية ، حيث تم ترتيب العينة وتقسيمها إلى إرباعيات وذلك حسب درجاتهم على مقياس الصلابة النفسية وتمت المقارنة بين الأرباع الأعلى والأرباع الأدنى في الاضطرابات السيكوسوماتية ، وجدول (2) يوضح قيم "ت" ودالاتها الإحصائية لدى منخفضي ومرتفعي الصلابة النفسية في الاضطرابات السيكوسوماتية :

جدول (2)

قيم " ت " ودالاتها الإحصائية لدى منخفضى ومرتفعى الصلابة النفسية فى الاضطرابات السيكوسوماتية

المتغير المقارنات	منخفضى الصلابة النفسية ن = 47		مرتفعى الصلابة النفسية ن = 45		قيمة " ت "	مستوى الدالة
	ع	م	ع	م		
اضطراب القلب والأوعية الدموية	2.42	8.91	2.32	7.8	2.63	دالة عند 0,01
اضطراب الجهاز الهضمي	2.57	9.36	2.39	8.31	1.99	دالة عند 0.05
اضطراب الجهاز العظمي	2.45	9.42	2.15	8.37	2.16	دالة عند 0.05
اضطراب الجهاز العصبي	2.54	11.41	2.38	10.43	1.9	دالة عند 0.05
تكرار المرض	2.08	7.63	1.9	6.7	2.22	دالة عند 0.05

من الجدول (2) يتضح وجود فروق بين مرتفعى الصلابة النفسية ومنخفضى الصلابة النفسية فى الاضطرابات السيكوسوماتية (اضطراب القلب والأوعية الدموية، اضطراب الجهاز الهضمي، اضطراب الجهاز العظمي، اضطراب الجهاز العصبي، تكرار المرض) لصالح منخفضى الصلابة النفسية ، وهذه النتيجة تفسر أن امتلاك أمهات

التوحديين لمستوى مرتفع من الصلابة النفسية يجعل اصابتهم بالاضطرابات السيكوسوماتية منخفض ، والعكس صحيح.

ترجع الباحثة هذه النتيجة الي طبيعة الصلابة النفسية بأن لديها علاقة بكل الصفات الإيجابية التي يمكن أن يتمتع بها الفرد، والتي تساعده علي تحمل مسؤولياته حتي في ظل الظروف التي تواجهه والعكس صحيح فأن الأشخاص السلبيين غير الواثقين من قدراتهم من الطبيعي أن ينخفض مستوي الصلابة لديهم ويكونوا أكثر عرضه للاضطرابات.

وأن هذه النتيجة تؤيد نظرية كوبازا في تحديدها للأفراد الذين يتمتعون بدرجة صلابة مرتفعة والتي تتمثل في قدرتهم علي الصمود والمقاومة، وامتلاكهم لوجهه ضبط داخلية وقدرة علي الالتزام والتحدي، حيث تعمل هذه العوامل كمتغيرات سيكولوجية تخفف من وقع الأحداث الضاغطة علي الصحة النفسية والجسمية لأمهات المعاقين. أما إنخفاض الصلابة النفسية يرتبط بشعور الأمهات بالسلبية في التفاعل مع البيئة الخارجية والعجز عن تحمل الآثار السلبية الناتجة عن وجود طفل توحدي في حياة الأم يهدد بطريقة مباشرة صحتها النفسية والجسدية، وهي سمات قد أشارت إليها دراسات سابقة (الوقفي،2008؛ حنصالي، 2014؛ أبو ندي، 2007؛ راضي، 2008).

توصيات الدراسة:

1. ضرورة تنمية الصلابة النفسية لدى الامهات ، وذلك من خلال البرامج الإرشادية والتدريبية التي تمكنهن من تنمية الصلابة النفسية لديهن لمواجهة الضغوط الناجمة من اضطرابات الابناء .
2. الاهتمام بالدراسات التي تهتم بالصلابة النفسية والاضطرابات الجسمية لدى الالباء بوجه عام أثناء التعامل مع الابناء الاسوياء وغير الاسوياء .

البحوث المقترحة:

تصميم وتنفيذ برامج أرشادية تقوم علي نظريات العلاج السلوكي العقلاني الوجداني لعلاج الاضطرابات النفسجسمية من خلال تنمية الصلابة النفسية.

إجراء بحوث في نفس المجال بعنوان:

- الصلابة النفسية.
- الاضطرابات السيكوسوماتية.

المراجع

المراجع العربية:

- أحمد إبراهيم (2020): التوحد بين ضرورة التشخيص المبكر وصعوباته، المجلة الاجتماعية القومية، المجلد 27 (2)، 51-52.
- الزهرة الأسود، ربيعة جعفرور (2010): مدي أنتشار الأمراض السيكوسوماتية بين أساتذة التعليم الثانوي، الملتقي الدولي الخاص المعانة في العمل، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر.
- أديب محمد الخالدي (2009): المرجع في الصحة النفسية .(ط3)، عمان: دار وائل النشر.
- بثية عبود، إلهام حفظ الله (2022): دراسة الاضطرابات السيكوسوماتية لدى أمهات التوحد، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة العربي بن مهيدي، ام البواقي.
- بوجمعة حافظ (2020): "مؤثرات الصلابة النفسية لدى الراشدين المتعافين من فيروس كورونا"، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة محمد بوضايا المسيلة.
- جمال خلف المقابلة (2016): اضطرابات طيف التوحد التشخيص والتدخلات العلاجية. ط1، الأردن ، دار يافا العلمية.

- حراث علي، خراب محمد عرفات (2018): الصلابة النفسية لدى طلبة البكالوريا، مجلة البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، مخبر تطوير الممارسات النفسية والتربوية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائر، (34)، 211-224.
- حامد عبد السلام زهران (2005): الصحة النفسية والعلاج النفسي، ط4، القاهرة، عالم الكتب.
- رائد خليل العبادي (2006): التوحد، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، الأردن.
- شيرين البدراوي عبدالتواب السعيد (2017): التوحد لدى الطفل، المجلة العلمية لكلية رياض الأطفال، 4(2)، 380-410.
- صالح علي أحمد قرني، جمال الدين محمد مزكي (2020): الصلابة النفسية وعلاقتها بتقدير الذات لدى طلاب المرحلة الثانوية بمحافظة الجموم، مجلة جامعة المدينة العالمية (مجمع)، (33)، 239-281.
- عبدالرحمن العيسوي (2000): الأضطرابات النفسجسمية، ط1، دار الراتب الجامعية، بيروت.
- عماد مخيمر (1997): الصلابة النفسية و المساندة الاجتماعية متغيرات وسيطة بين ضغوط الحياة وأعراض الاكتساب الجامعي، المجلة المصرية للدراسات النفسية، 7(17)، 1-20 .
- فريدة بن عيسي (2021): الأضطرابات السيكوسوماتية لدى أمهات أطفال التوحد، اطروحة ماجستير ف علم النفس العيادي، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواق.
- فؤاد حامد الموافي، ليلي عبد العظيم، داليا محمود الجنزوري (2017): فاعلية برنامج إرشادي لتنمية الصلابة النفسية لامهات المعافين حركياً. مجلة بحوث التربية النوعية، المنصورة، (45): 78-98.
- فيصل محمد الزراد (2000): الأمراض النفسية، جسمية، ط1، بيروت، دار النفائس.
- فاروق أسامة مصطفى، السيد كامل الشربيني (2011): التوحد الأسباب التشخيص_ العلاج، ط1، عمان دار المسيرة .

- منصور الشيخ (2019): الإساءة اللفظية الوالدية وعلاقتها بالاضطرابات السيكوسوماتية، مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس: جامعة دمشق_ كلية التربية، 17، (3)، 189.
- محمد صالح الامام، فؤاد عيد الجوالدة (2010): التوحد ونظرية العقل، ط1، عمان، دار الثقافة.

المراجع الأجنبية:

- Delorme, SI. (2021). Les Roles du Père à Aube de l'âge Adulte de son fils ayant Un Trouble du spectre de l'autisme. Essai Présenté comme exigence Partielle du Doctorat en Psychologie, Université du Québec à Montréal.
- Dunn, M. E., Burbine, T., Bowers, C. A., & TantleffDunn, S. (2001). Moderators of stress in parents of children with autism. Community Mental Health Journal.
- Health of Parents of Children with Autism Spectrum Disorders and Parents of Nondisabled Children in Croatia, Croatian National Institute of Public Health. .
- Judkinds, JL & Brian, AM & Tyler, CO. (2022). Psychological Hardiness. Department of Psychology, University of Texas at San.
- Rasool, RA. (2020). Psychological Hardiness among Undergraduate Students. International Journal of Social Relevance & Concern, 8 (10),1-15.
- Tomislav Benjak, Gorka Vuleti Mavrinacand Ivana Pavi Šimetin (2009): Comparative Study on Selfperceived

- WHO (World Health Organization) (2013): Autism spectrum disorders & other developmental disorders MEETING REPORT
From raising awareness to building capacity.
- Woods,P.J/ Lyons, L.C. (1990). Irrational Beliefs and Psychosomatic Disorders. Journal of Rationa_ Emotive and Cognitive _ Behavior Therapy, 8 (1), 3-20.